

Síntese das Regras de Prioridade no SUS

Pronto atendimento, triagem/ACCR, SAMU, UTI, regulação assistencial e transplante

Documento analítico para debate sobre priorização de pacientes em cenários de escassez

Escopo do documento

- Este relatório descreve como a prioridade é definida nos principais eixos assistenciais do SUS quando o recurso é escasso ou o tempo é crítico.
- O foco está na regra decisória: quem avalia, em que base avalia, quem entra na frente, o que pode reordenar a fila e como as normas do CFM reforçam ou limitam essa decisão.
- Onde houver protocolo local frequente, como o Protocolo de Manchester, ele é tratado como ferramenta operacional possível, e não como norma federal única do SUS.

Data: 12 de abril de 2026

Observação metodológica: As sínteses abaixo combinam normas do Ministério da Saúde, manuais oficiais de rede e resoluções do Conselho Federal de Medicina. Quando não existe uma regra nacional totalmente fechada para desempate entre casos equivalentes, isso é explicitado no texto.

1. Visão geral

O SUS já opera, em vários pontos da rede, com decisões fortemente protocolizadas de prioridade. A lógica geral não é “ordem de chegada”, mas uma combinação de gravidade, risco de agravamento, necessidade de intervenção imediata, potencial de benefício do recurso e organização regulada da oferta. Essa lógica aparece de formas diferentes em cada eixo: na triagem e no pronto atendimento, por meio do acolhimento com classificação de risco; no SAMU, por meio da regulação médica das urgências; na UTI, por critérios de admissão e benefício terapêutico; na regulação, por protocolos de acesso e gestão de fila; e no transplante, por regras nacionais informatizadas de alocação.

Leitura-chave para o debate

- A prioridade no SUS já é, em grande medida, uma decisão mediada por protocolo, formulário estruturado, classificação de risco e sistemas de informação.
- A decisão não é puramente “fria” nem puramente “subjettiva”: ela combina regra prévia, dados clínicos e revisão humana.
- O uso de analytics ou modelos predittivos faria mais sentido como camada adicional de apoio a esses protocolos, e não como substituto absoluto do profissional.

1.1 Matriz-resumo

Eixo	Norma-base principal	Quem decide	Regra sintética de prioridade	Papel do CFM
Pronto atendimento	Portaria GM/MS nº 2.048/2002 + protocolo ministerial de ACCR	Enfermeiro classificador; depois equipe médica	Atende antes quem apresenta maior gravidade, sinais de alerta e menor tempo seguro de espera.	Exige ACCR e atendimento médico de todo paciente em urgência/emergência.
Triagem / ACCR	Acolhimento com Classificação de Risco	Enfermeiro com protocolo	Estratifica risco; não fecha diagnóstico. Reclassifica se o quadro muda.	Reforça que a prioridade deve ser clínica, não cronológica.
SAMU	Regulação Médica das Urgências	Médico regulador	Julga gravidade à distância, seleciona recurso, define destino e pode usar vaga zero.	Define a regulação como ato médico e exige comando médico contínuo.
UTI	Resolução CFM nº 2.156/2016	Médico intensivista	Entra antes quem precisa de suporte intensivo e tem maior benefício esperado com a UTI.	É a norma mais explícita sobre critérios de admissão e prioridade.
Regulação	Portaria GM/MS nº 9.262/2025	Profissional regulador de nível superior	Fila pode ser reordenada por risco, tempo de espera, vulnerabilidade e barreiras de acesso.	Não há resolução específica do CFM equivalente; prevalece a política do SUS.
Transplante	Portaria GM/MS nº 8.041/2025 (rep. 2026) + SIGA/SNT	Equipe transplantadora + sistema nacional	Prioriza por compatibilidade, urgência, critérios do órgão e tempo em lista.	O núcleo decisório é do SNT; o CFM atua mais no plano ético e profissional.

1.2 Estrutura comum da decisão de prioridade

- Primeiro se identifica a urgência: o sistema precisa saber se há risco imediato de vida, sofrimento intenso ou chance relevante de deterioração rápida.
- Depois se mede o tempo seguro de espera: alguns pacientes podem aguardar com monitoramento; outros precisam de intervenção ou remoção imediata.
- Em seguida se escolhe o recurso: consulta médica rápida, sala de estabilização, ambulância, leito de UTI, vaga regulada, ou órgão ofertado.
- Por fim se define a ordem prática: o caso mais grave ou com maior benefício esperado recebe o recurso antes, desde que os critérios normativos daquele eixo sejam atendidos.

2. Pronto atendimento hospitalar e UPA 24h

Norma-base principal: Portaria GM/MS nº 2.048/2002; Portaria GM/MS nº 1.600/2011 (RUE); protocolo ministerial de acolhimento com classificação de risco; Resoluções CFM nº 2.077/2014 e nº 2.079/2014.

Como a prioridade funciona

No pronto atendimento, a decisão inicial de prioridade não nasce do diagnóstico definitivo nem da ordem de chegada. Ela nasce do acolhimento com classificação de risco (ACCR), processo em que o paciente é rapidamente avaliado e posicionado em um fluxo assistencial compatível com seu risco. O protocolo ministerial é explícito: a classificação de risco não é um instrumento de diagnóstico, e sim de hierarquização conforme a gravidade, com estratificação e definição de prioridade de atendimento.

A Rede de Atenção às Urgências (RUE) é a arquitetura que liga UPA, portas hospitalares, SAMU e leitos de retaguarda. Ela não é um algoritmo, mas o arranjo que permite que a prioridade definida na entrada se converta em destino assistencial adequado. Em outras palavras: o ACCR ordena a fila clínica; a RUE sustenta o fluxo da rede.

Na UPA 24h e em portas hospitalares, o ACCR separa pelo menos três grandes fluxos práticos: pacientes graves que vão diretamente para sala de estabilização ou atendimento médico imediato; pacientes com potencial de gravidade que precisam de avaliação rápida e monitoramento; e pacientes sem potencial de gravidade, que podem aguardar atendimento ambulatorial em tempo compatível com o risco.

Quem entra na frente

- Entra primeiro o paciente com sinais de morte iminente ou risco imediato de colapso: parada cardiorrespiratória, infarto em curso, choque hipovolêmico, politrauma grave, insuficiência respiratória importante, alteração neurológica profunda ou situação equivalente.
- Na sequência entram os pacientes com elevado risco de deterioração ou sofrimento relevante, ainda que não estejam em parada ou colapso: dispneia leve a moderada, convulsão cessada, trauma moderado, queimaduras menores, dor abdominal importante, cefaleia intensa, idosos e gestantes sintomáticos, entre outros exemplos do protocolo ministerial.
- Pacientes estáveis, sem risco atual de morte, mas com necessidade de consulta no mesmo turno, aguardam depois dos grupos acima. Queixas de baixa complexidade e sem sinais de alerta ficam para o final do fluxo.
- Quando o serviço usa Manchester ou equivalente, a lógica é semelhante: o discriminador clínico define um nível de urgência e um tempo-alvo de atendimento; porém a base conceitual continua sendo o ACCR. Manchester é uma ferramenta local comum, não a única norma nacional do SUS.

Quais variáveis realmente entram na decisão

- Queixa principal e modo de apresentação da doença.
- Sinais de alerta, como choque, palidez intensa, febre alta, desmaio, perda de consciência, desorientação, dor intensa e dificuldade respiratória.

- Sinais vitais, saturação de oxigênio, escala de dor, escala de coma de Glasgow, doenças preexistentes, idade e dificuldade de comunicação.
- Possibilidade de piora rápida enquanto aguarda e necessidade de reclassificação periódica.

O que o CFM acrescenta ou reforça

O CFM reforça que o ACCR deve existir de forma obrigatória nos serviços hospitalares de urgência e emergência e nas UPA 24h. Também determina que o acesso à classificação seja imediato e que nenhum paciente com agravo possa ser dispensado ou definitivamente encaminhado por profissional que não seja médico.

Nas UPA, o CFM acrescenta dois pontos práticos muito relevantes para a prioridade: pacientes instáveis ou com maior complexidade devem ser transferidos imediatamente ao hospital após estabilização, inclusive com uso de vaga zero quando necessário; e pacientes intubados, em ventilação mecânica, não devem permanecer na UPA aguardando indefinidamente leito hospitalar.

Cenário operacional típico

- Se chegam ao mesmo tempo um paciente com dor torácica e sudorese, um paciente com febre e tosse estável e um paciente com entorse de tornozelo, o primeiro recebe prioridade máxima do fluxo médico; o segundo pode entrar em prioridade intermediária conforme saturação e sinais de alerta; o terceiro aguarda por último.
- Se o paciente já chega pelo SAMU previamente classificado como grave, ele pode ir diretamente à sala de estabilização, sem passar pela espera comum.

Observação importante

- A classificação de risco não é uma vez por todas. Se o quadro muda na sala de espera, o paciente deve ser reclassificado.
- O CFM não fixa um único quadro nacional de cores e minutos para todas as instituições, mas exige o funcionamento do sistema e a precedência dos mais graves.

3. Triage / Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR)

Norma-base principal: Protocolo ministerial de acolhimento com classificação de risco; Portaria GM/MS nº 2.048/2002; Resoluções CFM nº 2.077/2014 e nº 2.079/2014.

Como a prioridade funciona

No vocabulário do SUS, a expressão mais precisa não é “triagem” em sentido meramente administrativo, mas acolhimento com classificação de risco. A diferença é decisiva: triagem poderia significar apenas ordenar, filtrar ou direcionar; ACCR significa receber o usuário, avaliar clinicamente o risco e reorganizar a fila segundo potencial de gravidade e tempo seguro de espera.

O protocolo ministerial atribui esse momento ao enfermeiro qualificado, com uso de protocolo e julgamento crítico. O enfermeiro não está fechando o diagnóstico médico do caso; está definindo o quanto aquele caso pode esperar sem aumentar desnecessariamente o risco.

O material do Ministério organiza a prioridade em categorias. Em sua formulação exemplificativa, prioridade zero/vermelha corresponde aos casos em morte iminente ou gravidade extrema; prioridade I/amarela corresponde a casos de elevado risco de morte ou deterioração; prioridade II/verde corresponde a urgências menores, que precisam

de consulta, mas não apresentam risco atual de morte. Protocolos locais mais detalhados podem desdobrar essa estratificação em mais níveis, como laranja e azul.

Quem entra na frente

- Vermelho: entra na frente quem precisa de atendimento imediato ou praticamente imediato. Exemplos clássicos do manual são parada cardiorrespiratória, infarto, politrauma e choque hipovolêmico.
- Amarelo: vem em seguida quem não está em colapso naquele minuto, mas carrega risco relevante de piora ou forte necessidade de avaliação célere. O protocolo inclui, entre outros, dispneia leve a moderada, trauma moderado, convulsão, dor abdominal importante e algumas apresentações de cefaleia.
- Verde: depois entram pacientes estáveis, sem risco atual de morte, mas que demandam consulta médica naquele período. O manual cita, por exemplo, ferimento craniano menor, diarreia, cefaleia menor, doença psiquiátrica e dor abdominal difusa sem sinais de gravidade.
- Categorias de menor urgência só esperam mais porque, naquele momento, têm maior segurança clínica para aguardar. A ordem não expressa valor moral do paciente; expressa risco temporal.

Quais variáveis realmente entram na decisão

- Nível de consciência e capacidade de responder verbalmente.
- Frequência respiratória, esforço respiratório, presença de cianose, ruídos respiratórios e saturação de oxigênio.
- Frequência cardíaca, qualidade do pulso, perfusão, palidez, sinais de choque ou descompensação.
- Escalas rápidas como dor e Glasgow, além da presença de comorbidades, idade extrema, gestação e barreiras de comunicação.
- Evolução dinâmica na sala de espera: qualquer deterioração muda a prioridade.

O que o CFM acrescenta ou reforça

O CFM converge com o Ministério da Saúde ao tratar a classificação de risco como eixo obrigatório do funcionamento da urgência. A mensagem central é que a prioridade precisa ser clínica. Nem idade isolada, nem ordem de chegada, nem pressão externa podem se sobrepor ao risco assistencial do momento.

Do ponto de vista ético e organizacional, o CFM também reforça que a classificação não substitui o atendimento médico. Ela organiza o acesso ao médico e ao recurso mais adequado.

Leitura operacional profunda do ACCR

- Um paciente que fala frases completas, ventila sem esforço, tem perfusão adequada e está orientado pode aguardar mais do que um paciente que fala pouco, apresenta cianose, pulso radial fino e confusão mental.
- A presença de dor intensa isolada não “vence” automaticamente sinais de insuficiência respiratória, alteração hemodinâmica ou rebaixamento do nível de consciência.
- Em sala de espera, o ACCR exige reclassificação: um paciente verde que piora para dispneia importante ou síncope deixa de ser verde.

Observação importante

- O ACCR é um exemplo claro de decisão semi-algoritmizada: usa critérios padronizados, variáveis clínicas objetivas e uma saída classificatória; ao mesmo tempo, depende de julgamento profissional e reavaliação contínua.

4. SAMU 192 e Regulação Médica das Urgências

Norma-base principal: Portaria GM/MS nº 2.048/2002; manual Regulação Médica das Urgências; Resolução CFM nº 2.110/2014; Portaria GM/MS nº 1.600/2011 (RUE).

Como a prioridade funciona

No SAMU, a prioridade nasce à distância, na Central de Regulação das Urgências. O primeiro contato coleta dados iniciais, mas a decisão técnica central é do médico regulador. É ele quem, em segundos ou poucos minutos, julga a gravidade presumida do evento, define a prioridade de resposta, escolhe o meio móvel e aponta o destino mais adequado dentro da rede.

A lógica da regulação médica não é apenas decidir “manda ambulância ou não”. Ela envolve quatro decisões concatenadas: classificação da demanda; seleção do recurso; acompanhamento da resposta; e definição do hospital ou serviço de destino. Em casos críticos, a melhor resposta pode ser disparada antes de se completar toda a coleta de informações, justamente porque o tempo é parte do risco.

O sistema admite vaga zero: quando o risco é alto e não há alternativa segura, o paciente grave é encaminhado a serviço capaz de recebê-lo, ainda que o leito formal ainda não esteja previamente disponibilizado. A prioridade clínica, nesses casos, prevalece sobre a conveniência administrativa da vaga.

Quem entra na frente

- No atendimento individual, entra na frente o caso que o médico regulador entende como de maior gravidade e maior necessidade de resposta imediata: parada cardiorrespiratória, trauma grave, rebaixamento importante da consciência, insuficiência respiratória aguda, dor torácica sugestiva de síndrome coronariana, AVC provável em janela, entre outros.
- Na disputa entre um caso leve e um caso potencialmente fatal, o recurso vai para o potencialmente fatal, ainda que o chamado leve tenha chegado antes.
- Em incidentes com múltiplas vítimas, a lógica muda de “melhor recurso para o paciente mais grave” para “melhor cuidado possível para o maior número de vítimas com os recursos disponíveis”. O manual operacional do SAMU orienta o uso de triagem rápida por START, baseada em respiração, perfusão e nível de consciência.
- No START, as vítimas classificadas como vermelhas/imediatas têm prioridade sobre amarelas/delayed e verdes/minor. Vítimas em óbito ou sem possibilidade de resposta naquele cenário entram em categoria preta/óbito-expectante conforme o protocolo local.

Quais variáveis realmente entram na decisão

- Relato do solicitante, localização, mecanismo do evento e número de vítimas.
- Informações sobre consciência, respiração, perfusão, sangramento, aprisionamento, risco ambiental e possibilidade de deterioração antes da chegada da equipe.
- Disponibilidade e tipo do recurso móvel (USB, USA, motolância, suporte aéreo, múltiplas equipes).
- Capacidade instalada da rede para receber o paciente e necessidade de ativação de vaga zero.
- No IMV, critérios START: respiração, perfusão e estado mental em avaliação muito rápida.

O que o CFM acrescenta ou reforça

O CFM é especialmente forte neste eixo. A Resolução nº 2.110/2014 define o atendimento pré-hospitalar móvel como serviço médico, estabelece a central de regulação como estrutura com médicos reguladores 24 horas por dia e afirma que a decisão técnica de todo o processo de regulação cabe ao médico regulador.

Essa resolução também exige que os atendimentos primários sejam priorizados por complexidade e não simplesmente por conveniência logística. Na prática, a urgência mais complexa e mais dependente de resposta rápida tem precedência.

Quando a equipe chega ao hospital com paciente grave, o CFM também organiza a transição: casos graves são entregues diretamente ao médico na sala de reanimação; os de menor complexidade podem seguir para acolhimento/classificação de risco no serviço receptor.

Se há 4 vítimas, mas só é possível remover 1 naquele momento

- Não se leva automaticamente a vítima que grita mais, nem a que parece pior visualmente sem triagem estruturada. Primeiro se aplica triagem rápida por respiração, perfusão e estado mental.
- Se houver uma vítima vermelha com obstrução respiratória corrigível ou choque reversível e outra preta sem sinais compatíveis com possibilidade de resposta naquele contexto, a vermelha tem prioridade absoluta para remoção.
- Se houver várias vermelhas, a escolha não é arbitrária: o médico regulador e o comando da cena priorizam a vítima com maior urgência vital e melhor possibilidade de benefício com o recurso disponível naquele intervalo, buscando salvar o maior número possível de vítimas.

Observação importante

- No SAMU, a decisão já nasce digitalizada e protocolizada: ficha de regulação, teleatendimento, despacho, registro de tempo-resposta e integração com destino hospitalar.
- Esse eixo é um dos mais próximos, no SUS, de uma lógica explícita de decisão remota orientada por protocolo.

5. UTI: admissão, prioridade e disputa por leito

Norma-base principal: Resolução CFM nº 2.156/2016.

Como a prioridade funciona

A UTI é o eixo em que a regra de prioridade está mais explicitamente escrita em norma profissional. A Resolução CFM nº 2.156/2016 determina que a admissão considere diagnóstico e necessidade do paciente, serviços disponíveis, priorização segundo a condição clínica, disponibilidade de leitos e potencial benefício das intervenções, à luz do prognóstico.

A norma também define os critérios de admissão: instabilidade clínica, necessidade de suporte a disfunções orgânicas e necessidade de monitorização intensiva. Não basta “estar grave” em sentido coloquial; é preciso que a complexidade do cuidado intensivo ofereça benefício concreto ao paciente.

Para operacionalizar isso, o CFM organiza cinco prioridades. Prioridade 1 é o paciente que precisa de suporte à vida e tem alta probabilidade de recuperação, sem limitação terapêutica. Prioridade 2 é o paciente que requer monitorização intensiva e tem alto risco de precisar intervenção imediata, também sem limitação terapêutica. Prioridade 3 inclui quem precisa de suporte à vida, mas tem baixa probabilidade de recuperação ou limitação terapêutica. Prioridade 4 envolve monitorização intensiva com limitação terapêutica. Prioridade 5 abrange paciente terminal ou moribundo, sem possibilidade de recuperação, em geral não apropriado para UTI, salvo exceções.

Quem entra na frente

- Se há um leito e dois pacientes, entra primeiro o paciente de prioridade mais alta conforme a resolução. Em regra, P1 vem antes de P2; P2 antes de P3 e P4; P5 em geral não é admitido em UTI.
- Entre dois pacientes da mesma prioridade, a decisão não é por ordem de chegada, influência social ou valor subjetivo da vida. O intensivista precisa comparar necessidade real de suporte intensivo, risco de deterioração imediata fora da UTI, benefício provável das intervenções e prognóstico clínico.
- Quando o paciente poderia ser adequadamente assistido em unidade intermediária ou semi-intensiva, a própria resolução orienta que essas estruturas sejam preferidas para P2 e P4, reservando a UTI para os casos em que o recurso intensivo é mais necessário.
- Pacientes em situação terminal, sem possibilidade de reversão e com indicação primária de cuidados paliativos, não devem ocupar a frente da fila de UTI diante de pacientes com necessidade intensiva e benefício esperável.

Quais variáveis realmente entram na decisão

- Instabilidade hemodinâmica, respiratória ou neurológica.
- Necessidade atual ou iminente de ventilação mecânica, drogas vasoativas, suporte avançado ou monitorização contínua complexa.
- Probabilidade de recuperação com o uso do leito intensivo.
- Existência ou não de limitação terapêutica previamente definida e adequação do nível de cuidado.
- Disponibilidade de leito e possibilidade de manejo seguro em unidade intermediária.

O que o CFM acrescenta ou reforça

Neste eixo, o CFM não apenas comenta: ele normatiza diretamente a prioridade. A admissão e a alta da UTI são competência do médico intensivista, e a decisão deve ser explícita, documentada e livre de discriminação indevida.

A resolução exige que cada instituição elabore protocolos locais de admissão e alta com base nesses critérios. Isso significa que pode haver detalhamento adicional local, mas a espinha dorsal obrigatória já está dada pelo CFM.

Do ponto de vista ético, a prioridade em UTI se ancora em necessidade, proporcionalidade e benefício, e não em critérios extraclínicos como notoriedade, poder econômico ou pressão política.

Se existe apenas 1 leito de UTI para 2 pacientes

- Paciente A: choque séptico, necessidade de noradrenalina e ventilação mecânica, sem limitação terapêutica e com chance razoável de reversão. Paciente B: monitorização intensiva por risco de piora, mas estável naquele momento. Pela lógica do CFM, o Paciente A entra na frente.
- Paciente A: insuficiência respiratória grave reversível com necessidade de suporte intensivo. Paciente B: doença terminal irreversível, sem possibilidade de recuperação, com indicação principal de cuidados paliativos. O Paciente A tem prioridade; o Paciente B, em regra, não é candidato apropriado ao leito de UTI.
- Se ambos são muito graves, a comparação se desloca para benefício provável e adequação do recurso. A UTI não é prêmio para o “mais doente” em abstrato; é recurso para quem mais precisa dela e mais pode se beneficiar dela.

Observação importante

- A resolução não cria um desempate matemático universal para todos os pacientes do mesmo estrato. Ela obriga um desempate clínico fundamentado, documentado e compatível com protocolo institucional.
- Esse ponto é crucial no debate: mesmo quando a norma é detalhada, a decisão continua humana; o algoritmo eventual entraria como apoio comparativo, não como soberano absoluto.

6. Regulação assistencial: fila, prioridade e reordenação do acesso

Norma-base principal: Portaria GM/MS nº 9.262/2025; Portaria Conjunta SAES/SEIDIGI nº 3/2023 (MIRA); Portaria GM/MS nº 6.656/2025.

Como a prioridade funciona

Na regulação assistencial, o recurso escasso não é apenas o leito; pode ser consulta especializada, exame, cirurgia, vaga em internação, porta hospitalar ou transporte sanitário. A Portaria GM/MS nº 9.262/2025 trata a regulação como função essencial do SUS e define que listas e filas são mecanismos baseados em critérios dos protocolos de acesso.

Esses protocolos de acesso devem reunir, no mínimo, grades de referência, fluxos assistenciais, requisitos de encaminhamento, classificação de risco e prioridade. Em termos práticos, a fila regulada não é uma fila “cega”; ela é uma fila continuamente passível de reordenação por critérios assistenciais.

A política atual é explícita ao dizer que a gestão das listas de espera deve considerar risco, tempo de espera e vulnerabilidade, e que estados e municípios devem incorporar critérios relacionados a barreiras de acesso, fatores epidemiológicos, socioculturais e geográficos. Portanto, a prioridade regulatória é multicritério.

Quem entra na frente

- Entra na frente quem, segundo o protocolo de acesso daquela linha de cuidado, apresenta maior risco de agravamento ou dano se continuar aguardando.
- Quando o risco clínico é semelhante, o tempo de espera ganha peso. A fila não ignora a cronologia, mas a cronologia não é o único critério.
- Em situações de maior vulnerabilidade ou barreira de acesso, a própria portaria permite que esses fatores reordenem a prioridade, desde que o critério seja público, normatizado e auditável.
- Na prática, isso significa que dois pacientes com a mesma solicitação não necessariamente entram na mesma posição final: um pode subir na fila por maior risco; outro, por tempo acumulado; outro, por vulnerabilidade combinada com risco.

Quais variáveis realmente entram na decisão

- Hipótese diagnóstica e justificativa clínica do encaminhamento.
- Critérios definidos no protocolo de acesso da especialidade, exame, procedimento ou internação.
- Tempo de espera já transcorrido.
- Marcadores de vulnerabilidade e barreiras geográficas, sociais ou funcionais, quando previstos pela gestão.
- Oferta real de agenda, leito, procedimento e referência disponível na rede.

O que o CFM acrescenta ou reforça

Aqui o CFM não ocupa o mesmo papel normativo central que tem na UTI ou no SAMU. O núcleo da prioridade regulatória é uma política pública do SUS, apoiada em protocolos de acesso e governança da rede.

Ainda assim, o raciocínio ético do CFM converge com essa lógica: a prioridade deve ser tecnicamente justificável, transparente, proporcional ao risco e não discriminatória.

Em especial, o CFM ajuda a afastar dois erros: transformar fila em mera ordem cronológica burocrática e transformar prioridade em favor pessoal ou político.

Como a fila é reordenada na prática

- Um pedido de especialidade pode subir de posição porque o paciente passou a apresentar sinais de agravamento previstos no protocolo de acesso, mesmo tendo sido inserido depois de outros.
- Um usuário com limitação funcional importante, necessidade de acompanhante contínuo ou barreira geográfica relevante pode receber tratamento prioritário quando o protocolo local incorporar vulnerabilidade e barreira de acesso, como autoriza a portaria.
- A política nacional exige publicidade dos critérios. Isso é essencial: fila regulada não pode ser ‘caixa-preta administrativa’; precisa ser explicável.

Observação importante

- O MIRA e o envio de dados à RNDS tornam esse eixo particularmente apto a analytics, porque a regulação passa a produzir dados comparáveis sobre tempo de espera, prioridade, solicitação e desfecho.
- Mas o uso de modelos preditivos só é legítimo se continuar subordinado aos protocolos de acesso e à revisão humana do regulador.

7. Transplante: lista única e algoritmo institucional de alocação

Norma-base principal: Portaria GM/MS nº 8.041/2025, republicada em 2026; Sistema Nacional de Transplantes (SNT); SIGA/SNT.

Como a prioridade funciona

O transplante é o eixo em que a decisão de prioridade já é mais claramente institucionalizada em forma algorítmica. O Sistema de Lista Única é gerido pelo SNT, via SIGA/SNT, e correlaciona características do doador e dos potenciais receptores para ordenar a alocação de cada órgão ou tecido doado.

A norma não trabalha com uma fila única simplista. Cada órgão possui sua lógica específica, mas há um conjunto comum de vetores: identidade ou compatibilidade ABO, urgência máxima quando aplicável, compatibilidade imunológica em alguns casos, características anatômicas e clínicas do doador, idade e peso em certos órgãos, regionalização/macrorregionalização e tempo em lista.

No fígado, por exemplo, a alocação considera, entre outros fatores, a pontuação MELD/PELD corrigida, com ordenação decrescente por gravidade clínica e uso do tempo em lista como componente de desempate. No rim, entram urgência máxima, compatibilidade HLA em situações previstas, estado de hipersensibilização e tempo em diálise/lista. Em cada órgão, a regra é técnica e rastreável.

Quem entra na frente

- Entra na frente o receptor que melhor satisfaz a regra técnica daquele órgão no momento da oferta, e não simplesmente o mais antigo da lista.
- A urgência máxima, quando formalmente reconhecida pela norma, antecede os demais candidatos compatíveis.
- Entre candidatos não urgentes, a combinação de compatibilidade biológica, critérios específicos do órgão e tempo em lista ordena a prioridade.
- Em casos de empate técnico residual, a própria norma prevê critérios adicionais de desempate, o que reforça o caráter estruturado e auditável da decisão.

Quais variáveis realmente entram na decisão

- Compatibilidade ABO e, quando aplicável, compatibilidade imunológica/HLA.
- Gravidade clínica formalizada segundo a regra do órgão, como MELD/PELD no fígado.
- Idade, peso e características antropométricas ou anatômicas relevantes.
- Tempo em lista ou tempo de diálise, conforme o caso.
- Regionalização, logística de captação/transporte e aceite da equipe transplantadora.

O que o CFM acrescenta ou reforça

Neste eixo, o CFM não é a fonte principal da ordem de prioridade. A regra nuclear vem do SNT e da portaria ministerial de transplantes.

A contribuição do CFM é mais indireta: ética profissional, deveres da equipe médica, qualidade do cuidado, legitimidade técnica da avaliação do receptor e do doador. A priorização formal, porém, é do sistema nacional de transplantes.

Isso torna o transplante um precedente especialmente forte para debates sobre algoritmo institucional: o país já aceita que uma regra técnica, informatizada e auditável ordene a oferta de um recurso vital escasso.

O que significa 'quem entra na frente' em transplante

- Não é necessariamente o paciente mais antigo da lista, nem o mais conhecido, nem o mais grave em abstrato. É o candidato que ocupa a primeira posição válida na combinação entre compatibilidade, urgência e critérios do órgão no momento concreto da oferta.
- No fígado, um paciente com maior MELD/PELD corrigido pode ultrapassar outro que espera há mais tempo, porque a gravidade clínica tem peso central.
- No rim, situações de urgência máxima ou compatibilidade excepcional podem alterar a frente da fila antes da simples cronologia.

Observação importante

- Transplante é o exemplo mais sólido de que a priorização em saúde pode ser fortemente protocolizada, informatizada e ainda assim legitimada institucionalmente.
- Ao mesmo tempo, o processo não é puramente automático: equipes atualizam dados clínicos, aceitam ou recusam órgãos justificadamente e o sistema opera dentro de forte controle regulatório.

8. Síntese comparativa para o debate

Os seis eixos analisados mostram graus diferentes de formalização, mas convergem em uma mesma estrutura: há uma regra prévia, há dados clínicos e organizacionais que alimentam essa regra, e há supervisão humana. O ponto não é escolher entre “média estatística fria” e “decisão humana pura”. O ponto é reconhecer que o SUS já opera com prioridade estruturada e que, em vários locais, a alternativa à regra não é um humanismo pleno, mas uma mistura de subjetividade, fila cronológica inadequada e variação injustificada.

Tese sintética

- No pronto atendimento e na triagem, a regra central é o risco temporal: entra antes quem menos pode esperar.
- No SAMU, a regra central é a melhor resposta possível para a maior urgência com os recursos disponíveis, sob regulação médica.
- Na UTI, a regra central é necessidade de cuidado intensivo combinada com benefício provável do leito.
- Na regulação, a regra central é a fila reordenável por risco, tempo de espera e vulnerabilidade.
- No transplante, a regra central já é um algoritmo institucional auditável de compatibilidade, urgência e critérios específicos do órgão.

Assim, um modelo de Big Data ou predição não começaria do zero. Ele só seria defensável se funcionasse como camada de apoio a regras já legitimadas, ajudando a detectar deterioração, reordenar filas com mais consistência, padronizar variáveis e reduzir a arbitrariedade — sempre preservando revisão humana, transparência e possibilidade de contestação.

9. O que efetivamente diz o CFM sobre prioridade

O CFM é central em quatro pontos: (1) tornar obrigatório o funcionamento do ACCR em urgência hospitalar e UPA; (2) afirmar que nenhum paciente com agravo pode ser simplesmente dispensado sem avaliação médica; (3) definir o atendimento pré-hospitalar móvel e a regulação das urgências como atos médicos sob comando do médico regulador; e (4) normatizar, de forma detalhada, a admissão e a priorização em UTI.

Nos eixos de regulação assistencial e transplante, o protagonismo normativo recai mais diretamente sobre o Ministério da Saúde e o SNT do que sobre o CFM. Isso não significa ausência de ética médica; significa apenas que a ordem formal da prioridade está no arranjo regulatório do SUS e não em resolução própria do CFM.

Em conjunto, as normas do CFM caminham no mesmo sentido: a prioridade deve ser técnica, documentada, proporcional ao risco e à necessidade, e nunca capturada por ordem de chegada pura, privilégio extraclínico ou imprevisto.

10. Referências normativas e documentais essenciais

- Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 2.048, de 5 de novembro de 2002. Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência.
- Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.600, de 7 de julho de 2011. Reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no SUS.
- Ministério da Saúde. Acolhimento com Classificação de Risco nos Serviços de Urgência.
- Ministério da Saúde. Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco.

- Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.077/2014. Normatiza o funcionamento dos Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência.
- Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.079/2014. Normatiza o funcionamento das UPA 24h e congêneres.
- Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 1.451/1995. Define urgência e emergência.
- Ministério da Saúde. Regulação Médica das Urgências.
- Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.110/2014. Dispõe sobre a normatização do atendimento pré-hospitalar móvel.
- SAMU 192 / BVS. Manual Técnico Operacional da Central SAMU 192 (conteúdo sobre incidentes com múltiplas vítimas e START).
- Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.156/2016. Critérios de admissão e alta em unidade de terapia intensiva.
- Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 9.262, de 31 de dezembro de 2025. Institui a Política Nacional de Regulação em Saúde.
- Ministério da Saúde. Portaria Conjunta SAES/SEIDIGI nº 3, de 18 de abril de 2023. Institui o Modelo de Informação da Regulação Assistencial (MIRA).
- Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 6.656, de 10 de março de 2025. Dispõe sobre o envio de dados de regulação para a RNDS.
- Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 8.041, de 19 de dezembro de 2025, republicada em 21 de janeiro de 2026. Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplantes.

URLs oficiais consultadas

- BVS/Ministério da Saúde – Protocolo de acolhimento com classificação de risco.
- BVS/Ministério da Saúde – Portaria GM/MS nº 2.048/2002.
- BVS/Ministério da Saúde – Portaria GM/MS nº 1.600/2011.
- Portal CFM – Resoluções nº 2.077/2014, nº 2.079/2014, nº 2.110/2014 e nº 2.156/2016.
- BVS/Ministério da Saúde – Regulação Médica das Urgências.
- BVS/Ministério da Saúde – Política Nacional de Regulação em Saúde (Portaria nº 9.262/2025).
- BVS/Ministério da Saúde – MIRA e Portaria nº 6.656/2025.
- BVS/Ministério da Saúde – Regulamento Técnico do SNT (Portaria nº 8.041/2025, republicada em 2026).